

TEMA 4.11 • GASTROENTEROLOGÍA

Hepatitis Aguda y Crónica

PERFIL EUNACOM 1.06.1.019
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Hepatitis

Definición y Clasificación

Hepatitis = elevación de transaminasas: **AST (GOT)** y **ALT (GPT)**.

TABLA 4.11.1: TIPO VS TIEMPO		
TIPO	TIEMPO	CAUSAS PRINCIPALES
Aguda	< 6 meses	VHA, VHB, VHE, Herpes (VEB, CMV), alcohol, fármacos, tóxicos
Crónica	> 6 meses	NASH, VHB, VHC, Hepatitis autoinmune

Riesgo Principal según Tipo

TABLA 4.11.2: TIPO VS RIESGO		
TIPO	RIESGO	EXAMEN CLAVE
Aguda	Hepatitis fulminante (ictericia + encefalopatía)	Tiempo de protrombina (TP)
Crónica	Cirrosis / daño hepático crónico	Biopsia hepática (inflamación + fibrosis)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Hepatitis fulminante = ictericia + encefalopatía hepática (desorientación, asterixis). Alta mortalidad. Candidatos a trasplante urgente. El TP es el marcador pronóstico.

Hepatitis Agudas

Hepatitis A (VHA)

- **Contagio:** fecal-oral (también sexual, práctica fecal-oral)
- **Clínica clásica:** pródromo (fiebre, malestar) → ictericia + coluria + acolia
- **Diagnóstico:** **IgM anti-VHA** (infección activa aguda)
- Si **IgG anti-VHA (+)**: ya tuvo o está vacunado → no requiere vacuna
- **Tratamiento:** soporte + medidas de higiene (lavado de manos, no manipular alimentos)
- Pedir **TP** para descartar riesgo de hepatitis fulminante (riesgo ~0,1% = 1/1.000)

Formas atípicas

TABLA 4.11.3: FORMA VS DESCRIPCIÓN	
FORMA	DESCRIPCIÓN
Silente	Totalmente asintomática (frecuente en niños)
Recurrente	Mejora y hace nueva hepatitis (reacción inmune, no reactivación viral)
Colestásica	En vez de hepatitis → eleva FA y GGT (colestasia)

Manejo de contactos

TABLA 4.11.4: CONTACTO VS CONDUCTA	
CONTACTO	CONDUCTA
Extradomiciliario (colegio, etc.)	Vacuna anti-VHA
Intradomiciliario (hermanos, convivientes)	Inmunoglobulina específica anti-VHA o genérica

Hepatitis B (VHB)

- **Contagio:** sexual (principal) y parenteral (accidente cortopunzante → 30% de riesgo)

- **90% aguda, 10% crónica** (regla general: NO crónica)
- Riesgo hepatitis fulminante: **1%** (10 veces más que VHA)

Marcadores serológicos — Lo que EUNACOM pregunta

TABLA 4.11.5: MARCADOR VS INTERPRETACIÓN	
MARCADOR	INTERPRETACIÓN
AgHBs (+)	Tiene infección (virus presente)
IgM anti-HBc (+)	Infección aguda (activa)
AgHBs (+) + IgM anti-HBc (+)	Hepatitis B aguda
AgHBs (+) + IgM anti-HBc (-)	Hepatitis B crónica
AgHBs (-) + IgM anti-HBc (+)	Período de ventana (infección aguda, antígeno aún negativo)
IgG anti-HBs (+)	Protegido (vacunado o curado) — NO pide de rutina
IgG anti-HBc (+)	Estuvo expuesto (no dice si activo o curado) — confunde, no pedir

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Mnemotecnia: AgHBs = "tengo el virus". IgM anti-HBc = "es agudo". Si solo IgM (+) sin antígeno = período de ventana. La vacuna solo genera **IgG anti-HBs**, NO anti-HBc → si el paciente tiene anti-HBc positivo, no es vacunado.

Tratamiento

- **Agudo:** soporte + TP para vigilar fulminante
- **Crónico:** antivirales + interferón (no memorizar fármacos específicos)

Manejo de contactos

- Vacuna contra VHB (regla general)
- **Exposición reciente** (sexual/cortopunzante): inmunoglobulina específica + vacuna
- **Recién nacido de madre VHB (+):** vacuna + IgG específica (no contraindica **lactancia materna**)

Hepatitis C (VHC)

- **100% crónica** (solo 10% no crónica)
- No da hepatitis aguda clínicamente manifiesta
- **Diagnóstico:** anticuerpos totales anti-VHC → confirmar con **PCR** (porque el 10% no cronifica pero tiene anticuerpos)
- **Tratamiento:** antivirales + interferón + biopsia hepática (para estadificar)
- Solo hace hepatitis crónica → deriva siempre a especialista

Hepatitis Alcohólica

- **Antecedente:** **Consumo de Alcohol: Alcoholismo y Síndromes de Abstinencia**consumo de alcohol
- **Diagnóstico:** GOT/GPT elevadas **con relación GOT:GPT > 2** (relación inusual)
- Marcadores adicionales: ↑ GGT, ↑ VCM (**Anemia: Generalidades**anemia macrocítica)
- **Tratamiento:** soporte; si muy grave (TP alargado) → agregar **corticoides**

Hepatitis por Fármacos

- Cualquier fármaco puede causarla
- **Clásicos:** paracetamol, fármacos antituberculosos (pirazinamida, etambutol, rifampicina, isoniazida)
- **Conducta siempre: suspender el fármaco** de inmediato

- **Paracetamol:** antídoto = **N-acetilcisteína**
- **Antituberculosos:** suspender todos y derivar para identificar el culpable; pirazinamida es la más frecuente

Hepatitis Crónicas

NASH (Esteatohepatitis No Alcohólica)

- **Causa:** resistencia a la insulina
- **Contexto:** obesidad, DM tipo 2, dislipidemia
- **Eco:** hígado hiperecogénico (blanco brillante) que se difumina en profundidad
- **Tratamiento:** dieta + ejercicio + metformina (tratar la resistencia insulínica)
- Diagnóstico de exclusión: descartar VHB, VHC y hepatitis autoinmune primero

Hepatitis Autoinmune

- **Marcadores:** ANA + ASMA (anti-músculo liso) + anti-LKM1
- **Contexto:** paciente con otra enfermedad autoinmune (ej. hipotiroidismo)
- **Confirmar:** biopsia hepática (inflamación de hepatocitos)
- **Tratamiento:** corticoides + inmunomoduladores

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Mnemotecnia hepatitis autoinmune: ANA tiene ASMA y hepatitis autoinmune (+ anti-LKM1). ANA = nombre, ASMA = enfermedad, hepatitis autoinmune = diagnóstico.

CBP — Cirrosis Biliar Primaria

- **Tipo:** colestasia crónica (no hepatitis) → ↑ FA, GGT, bilirrubina
- **Marcador:** **AMA** (anticuerpos antimitocondriales)
- **Perfil:** mujer 40-50 años, multipara, con **prurito intenso** (síntoma principal)
- **Confirmar:** biopsia (linfocitos atacan conductos biliares intrahepáticos)
- **Tratamiento:** ácido ursodesoxicólico

CEP — Colangitis Esclerosante Primaria

- **Tipo:** colestasia crónica → ↑ FA, GGT, bilirrubina
- **Marcador:** **ANCA** (anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos — mismo de colitis ulcerosa)

- **Contexto asociado:** **Colitis ulcerosa** (hombre joven con CU que hace ictericia)
- **Diagnóstico:** **colangio-resonancia** (imagen en "rosario": estenosis alternada con dilatación)
- **Tratamiento:** ácido ursodesoxicólico

Tratamiento Final de todas las Hepatitis Crónicas y Colestasias Crónicas

- Si evolucionan a cirrosis → manejo del daño hepático crónico + **trasplante hepático**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente con hepatitis aguda. El antígeno de superficie para hepatitis B es positivo y la IgM anti-core es negativa. ¿Cuál es la interpretación?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Hepatitis Aguda y Crónica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Hepatitis aguda: riesgo de fulminante (ictericia + encefalopatía); monitorear con TP
- Hepatitis A: fecal-oral, IgM diagnóstica, riesgo fulminante 0.1%; contactos intradomiciliarios = inmunoglobulina
- Hepatitis B: HBsAg + IgM anti-core para diagnóstico; 90% aguda/10% crónica; riesgo fulminante 1%
- Hepatitis C: solo crónica; anticuerpos totales + PCR confirmatoria; 90% cronifica
- Relación GOT/GPT >2 = hepatitis alcohólica
- NASH: resistencia a insulina; tratamiento = dieta + ejercicio + metformina
- Hepatitis autoinmune: ANA/ASMA/anti-LKM1; CBP: AMA + prurito en mujeres; CEP: ANCA + colitis ulcerosa
- Paracetamol: antídoto N-acetilcisteína; fármacos antituberculosos: suspender todos

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HEPATITIS AGUDA Y CRÓNICA)

PREGUNTA 1

Paciente con hepatitis aguda. El antígeno de superficie para hepatitis B es positivo y la IgM anti-core es negativa. ¿Cuál es la interpretación?

- A) Hepatitis B aguda
- B) Hepatitis B crónica
- C) Hepatitis B en periodo de ventana
- D) Paciente vacunado contra hepatitis B
- E) Hepatitis B curada

PREGUNTA 2

Mujer de 48 años, múltipara, consulta por prurito intenso generalizado e ictericia leve. Las pruebas hepáticas muestran elevación de fosfatasa alcalinas y GGT con transaminasas normales. ¿Cuál es el anticuerpo a solicitar?

- A) ANA
- B) ANCA
- C) AMA (antimitocondriales)
- D) ASMA
- E) Anti-LKM1

PREGUNTA 3

Paciente con antecedente de consumo crónico de alcohol presenta ictericia y hepatomegalia. Las transaminasas muestran GOT de 350 y GPT de 120. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Hepatitis viral aguda
- B) Hepatitis alcohólica
- C) NASH
- D) Hepatitis autoinmune
- E) Hepatitis por fármacos

RESUMEN: HEPATITIS AGUDA Y CRÓNICA

Clase densa sobre hepatitis aguda y crónica. Las hepatitis agudas (virus A/B/E, herpes, alcohol, fármacos) tienen riesgo de hepatitis fulminante (ictericia + encefalopatía); se monitorean con TP. Las hepatitis crónicas (NASH, virus B/C, autoinmune) tienen riesgo de cirrosis; se evalúan con biopsia hepática. Hepatitis A: fecal-oral, IgM diagnóstica, riesgo fulminante 0.1%. Hepatitis B: sexual/parenteral, antígeno de superficie + IgM anti-core; 90% aguda, 10% cronifica. Hepatitis C: solo crónica (90% cronifica), anticuerpos totales + PCR confirmatoria. Enfermedades hepáticas autoinmunes: hepatitis autoinmune (ANA/ASMA/anti-LKM1, corticoides), cirrosis biliar primaria (AMA, colestasia, mujeres, prurito), colangitis esclerosante primaria (ANCA, colangioRNM, asociada a colitis ulcerosa). NASH: resistencia a insulina, ecografía hiperecogénica, tratamiento con dieta/ejercicio/metformina.